

DANS CE SUJET

AUTRES SUJETS DANS CE CHAPITRE

→ Douleurs pelviennes au début de la grossesse

→ Saignement vaginal en début de grossesse

→ Nausées et vomissements au début de la grossesse

→ Œdème des membres inférieurs en fin de grossesse

→ Saignement vaginal en fin de grossesse

→ Fièvres pendant la grossesse

Douleurs pelviennes au début de la grossesse



Par **Emily E. Bunce**, MD, Wake Forest School of Medicine;
Robert P. Heine, MD, Wake Forest School of Medicine
Reviewed By **Oluwatosin Gaje**, MD, MSCR, Cleveland Clinic, Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University

Vérifié/Révisé juil. 2023 | Modifié sept. 2025

Étiologie | Bilan | Traitement | Points clés | Multimédia

La **douleur pelvienne** est fréquente au début de la grossesse et peut accompagner des troubles graves ou mineurs. Certaines pathologies à l'origine de douleurs pelviennes peuvent également entraîner des saignements vaginaux. Dans certains de ces troubles (p. ex., rupture de grossesse extra-utérine, rupture hémorragique de corps jaune), le saignement peut être sévère, conduisant parfois à un choc hémorragique.

Les causes de douleurs abdominales généralisées sont les mêmes que chez la femme non enceinte.

Étiologie

Les causes des douleurs pelviennes précoces au cours de la grossesse (voir tableau [Certaines causes de douleurs pelviennes](#)) peuvent être

- Obstétricales
- Gynécologiques
- Non gynécologiques

Parfois, aucune étiologie particulière n'est identifiée.

Les causes obstétricales les plus fréquentes de douleurs pelviennes en début de grossesse sont

- Les modifications normales de la grossesse
- **Avortement spontané** (menace d', inévitable, incomplet, complet, manqué ou septique)

Les complications obstétricales les plus graves sont

- Rupture de **grossesse extra-utérine**

Les causes gynécologiques comprennent la **torsion annexielle**, plus fréquente pendant la grossesse car le corps jaune provoque une augmentation de la taille des ovaires, augmentant ainsi le risque de torsion de l'ovaire autour de son pédicule.

Les causes non gynécologiques comprennent les pathologies génito-urinaires et digestives:

- **Gastro-entérites** virales
- **Syndrome du côlon irritable**
- **Appendicite**
- **Maladie intestinale inflammatoire**
- **Infection urinaire**
- **Lithiase urinaire**

En fin de grossesse, la douleur pelvienne peut résulter du travail, de complications obstétricales ou de l'une des nombreuses causes non obstétricales de douleur pelvienne.

Bilan

Le bilan des patientes qui ont des douleurs pelviennes en début de grossesse doit éliminer les causes graves potentiellement curables (p. ex., grossesse extra-utérine rompue, avortement septique, appendicite).

Anamnèse

L'**anamnèse de la maladie actuelle** doit comprendre la date prévue de l'accouchement (et si elle est basée sur la dernière période menstruelle ou l'échographie), tous les facteurs de risque de complications obstétricales, et les tests antérieurs ou les complications pendant la grossesse actuelle. Elle doit comprendre tous les événements associés à l'apparition de la douleur (p. ex., un traumatisme physique) et les caractéristiques de la douleur: début (soudain ou progressif), localisation (localisée ou diffuse), caractère (crampes, coliques ou intense), motif (constant ou intermittent), et l'effet des mouvements. Toute fièvre, frissons ou hémorragie vaginale doit être notée. Un antécédent d'interruption illégale ou auto-induite de grossesse doit faire évoquer un avortement septique, mais son absence n'élimine pas le diagnostic.

La **revue des systèmes** doit rechercher les symptômes génito-urinaires et digestifs en faveur d'une cause.

Les symptômes génito-urinaires et les étiologies importants suggérés comprennent

- Saignements vaginaux: **grossesse extra-utérine** ou **avortement**
- Syncope ou quasi-syncope: grossesse extra-utérine
- Pollakiurie, urgenterie ou dysurie: **infection urinaire**
- Écoulement vaginal avec fièvre: **maladie inflammatoire pelvienne**

Les symptômes gastro-intestinaux et les étiologies importants suggérés comprennent

- Une diarrhée: **gastro-entérite**, **maladie intestinale inflammatoire** ou **syndrome de l'intestin irritable**
- Vomissements: du fait de nombreux troubles, notamment gastro-entérite et **occlusion intestinale**
- Constipation: **occlusion intestinale**, intestin irritable ou **trouble fonctionnel**

La recherche des **antécédents médicaux** doit porter sur le nombre de grossesses confirmées, la gestité (nombre d'accouchements à terme et prématurés) et le nombre d'avortements (spontanés ou provoqués) et des questions sur des troubles connus pour causer des douleurs pelviennes (p. ex., maladie intestinale inflammatoire, syndrome de l'intestin irritable, néphrolithiase, grossesse extra-utérine, fausse couche spontanée). Les facteurs de risque de ces troubles doivent être identifiés.

Les **facteurs de risque les plus importants** de grossesse extra-utérine comprennent les suivants

- Antécédents de grossesse extra-utérine (le plus important)
- Antécédent de chirurgie abdominale (chirurgie tubaire en particulier, p. ex., ligature des trompes)
- Anomalies tubaires (p. ex., hydrosalpinx)
- Utilisation actuelle de dispositifs intra-utérins
- Fécondation in vitro pour la grossesse actuelle

Les facteurs de risque supplémentaires de grossesse extra-utérine comprennent des antécédents d'infection sexuellement transmissible ou de maladie pelvienne inflammatoire, l'utilisation actuelle de contraceptifs oraux œstrogènes/progestatifs, le tabagisme, l'infertilité et un avortement spontané ou provoqué antérieur.

Les **facteurs de risque de fausse couche spontanée** comprennent

- Âge > 35 ans
- Antécédents de fausse couche spontanée
- Tabagisme
- Drogues ou autres substances illicites (p. ex., cocaïne, éventuellement alcool ou fortes doses de caféine)
- Anomalies utérines (p. ex., léiomyome, adhérences)

Les **facteurs de risque d'occlusion intestinale** comprennent

- Antécédents de chirurgie abdominale
- Hernie
- Maladie maligne intra-abdominale

Examen clinique

L'évaluation des patientes pendant la grossesse doit comprendre une évaluation prénatale systématique de l'état de la mère et du fœtus, dont

- Évaluation des signes vitaux maternels
- Examen abdominal pour la mesure de la hauteur du fond
- Parfois, examen pelvien
- Évaluation du statut fœtal avec auscultation de la fréquence cardiaque fœtale
- Parfois, échographie pelvienne (en fonction des symptômes et de l'âge gestationnel)

L'examen clinique visant à évaluer la douleur pelvienne consiste à rechercher une fièvre et des signes d'hypovolémie (hypotension, tachycardie).

L'abdomen est palpé à la recherche d'une sensibilité, de signes péritonéaux (douleur à la décompression, rigidité, défense) et pour évaluer la taille de l'utérus, percuté à la recherche d'un tympanisme.

L'examen pelvien comporte l'inspection du col à la recherche d'un écoulement, d'une dilatation et des hémorragies. Les pertes vaginales ou cervicales, le cas échéant, doivent être prélevées et testées à la recherche d'une infection, si une **vaginite** ou une **cervicite** sont suspectées.

L'examen bimanuel doit rechercher une douleur à la mobilisation du col utérin, des masses ou des douleurs annexielles, et évaluer la taille de l'utérus. Si une **grossesse extra-utérine** est suspectée, l'examen pelvien doit être effectué avec soin sans exercer de pression excessive sur les annexes, ce qui pourrait provoquer la rupture d'une grossesse tubaire.

Signes d'alarme

Les signes suivants sont particulièrement préoccupants:

- Instabilité hémodynamique (hypotension et/ou tachycardie)
- Syncope ou quasi-syncope
- Signes péritonéaux (douleur à la décompression, rigidité, défense)
- Fièvre, frissons et/ou écoulement vaginal purulent
- **Saignements vaginaux**

Interprétation des signes

Certains signes suggèrent des causes de douleurs pelviennes mais ne sont pas toujours spécifiques (voir tableau [Certaines causes de douleurs pelviennes](#)).

Chez toutes les femmes présentant des douleurs pelviennes en début de grossesse, l'étiologie la plus grave, **grossesse extra-utérine**, doit être exclue, indépendamment de tout autre résultat. Les causes non obstétricales de douleur pelvienne (p. ex., une appendicite aiguë) doivent toujours être évaluées (cas des femmes non enceintes).

Comme chez toute patiente, les signes d'irritation péritonéale (p. ex., douleur focale, défense, douleur à la décompression, rigidité) sont préoccupants. Les causes fréquentes comprennent l'appendicite, la rupture d'une grossesse extra-utérine, et, moins souvent, kyste ovarien rompu. Cependant, l'absence d'irritation péritonéale n'élimine pas une urgence et il faut rester vigilant.

Les signes qui orientent vers une cause comprennent

- Un saignement vaginal accompagnant la douleur: fausse couche spontanée ou une grossesse extra-utérine
- Un orifice cervical ouvert ou la présence de tissus non expulsés dans le col ou le vagin: généralement un avortement inévitable, incomplet ou complet
- Une fièvre, des frissons et un écoulement vaginal purulent évoquent un avortement septique (en particulier en cas d'antécédent d'acte opératoire endo-utérin ou d'avortement clandestin)

La **maladie pelvienne inflammatoire** est rare pendant la grossesse

Examens complémentaires

Si une cause obstétricale de douleur pelvienne est suspectée, la mesure quantitative de la bêta-hCG, et une NFS doivent être effectuées.

Si la patiente présente également des saignements vaginaux ou qu'une hémorragie interne est suspectée, un groupage sanguin et un typage Rh sont effectués. Si la patiente est hémodynamiquement instable (avec hypotension et/ou tachycardie persistante), le sang doit être cross-matché et les taux de fibrinogène, de produits de dégradation de la fibrine et le temps de prothrombine [temps de Quick (TQ)]/temps partiel de thromboplastine (= TPP, TCK, TCA, TPP) sont mesurés.

Si une grossesse extra-utérine est suspectée, des tests de la fonction rénale et hépatique peuvent être effectués à l'avance, car ils seront nécessaires pour exclure une maladie rénale ou hépatique avant l'administration de méthotrexate.

Une échographie pelvienne est effectuée pour confirmer une grossesse intra-utérine et évaluer ce qui suit

- Rythme cardiaque, taille et mouvements fœtaux
- Pathologie utérine
- Une masse sur la trompe de Fallope ou ovarienne ou d'autres anomalies
- Liquide libre dans le bassin

L'échographie transabdominale et transvaginale doit être utilisée si nécessaire. Si l'utérus est vide et que la patiente n'a pas noté d'élimination de tissu par le vagin, une grossesse extra-utérine est suspectée. Lorsque l'échodoppler montre un flux sanguin vers les annexes absent ou diminué, une torsion annexielle (ovaires) est suspectée. Cependant, ce résultat n'est pas toujours présent parce qu'une détorsion spontanée peut survenir.

Cependant, l'échographie peut et doit être reportée si la patiente est hémodynamiquement instable pour accélérer le traitement chirurgical en cas de positivité du test de grossesse, étant donné le risque très élevé de grossesse extra-utérine ou de fausse couche spontanée avec hémorragie.

La laparoscopie peut être utilisée pour diagnostiquer une douleur qui reste significative et non diagnostiquée après l'évaluation habituelle.

Traitement

Le traitement de la douleur pelvienne en début de grossesse est dirigé contre la cause.

Si la **grossesse extra-utérine** est confirmée et n'est pas rompue, un traitement médical par méthotrexate peut souvent être envisagé, et en alternative une salpingotomie ou une salpingectomie. Si une rupture de la grossesse extra-utérine est suspectée, le traitement consiste en une laparoscopie ou une laparotomie immédiate.

Le traitement des **fausses couches spontanées** dépend du type d'avortement et de la stabilité hémodynamique. Les menaces d'avortement sont traitées d'une manière conservatrice avec antalgiques par voie orale. Les avortements inévitables, incomplets ou méconus sont traités médicalement par misoprostol ou chirurgicalement par évacuation utérine par dilatation et curetage. Les avortements septiques sont traités par évacuation utérine plus des antibiotiques IV.

Les femmes qui ont un **groupe sanguin Rh négatif** et qui ont des saignements vaginaux ou une grossesse extra-utérine doivent recevoir des immunoglobulines Rho(D) pour éviter une **allo-immunisation**.

Les **ruptures de kystes du corps jaune** et la **dégénérescence d'un fibrome utérin** sont traitées de manière conservatrice par des antalgiques par voie orale.

Le traitement des **torsions annexielles** est chirurgical:

- Si l'ovaire est viable: détorsion manuelle
- Si l'ovaire est infarci et non viable: ovariectomie ou salpingectomie

Points clés

- Les douleurs pelviennes en début de grossesse doivent toujours faire évoquer une grossesse extra-utérine.
- Envisager des étiologies non obstétricales comme cause d'un abdomen aigu pendant la grossesse.
- Si aucune cause claire non obstétricale n'est identifiée, une échographie est habituellement nécessaire.
- Un avortement septique doit être suspecté en cas d'antécédents de manœuvres instrumentales endo-utérines récentes ou d'avortement provoqué.
- Déterminer le groupe sanguin et le statut Rh chez toutes les femmes en début de grossesse; en cas de saignements vaginaux abondants ou de grossesse extra-utérine, toutes les femmes ayant un sang Rh négatif doivent recevoir des immunoglobulines Rho(D).



TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Take a Quiz!

Téléchargez gratuitement l'application Manuels MSD



Scannez le code pour télécharger dès maintenant

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play